



Mahidol University
Wisdom of the Land

Perioperative Nursing Breast surgery

นางสาวธัญชนก จิรภัตตานนท์
โรงพยาบาลศิริราช
หน่วยผ่าตัดศีรษะ คอ เต้านม

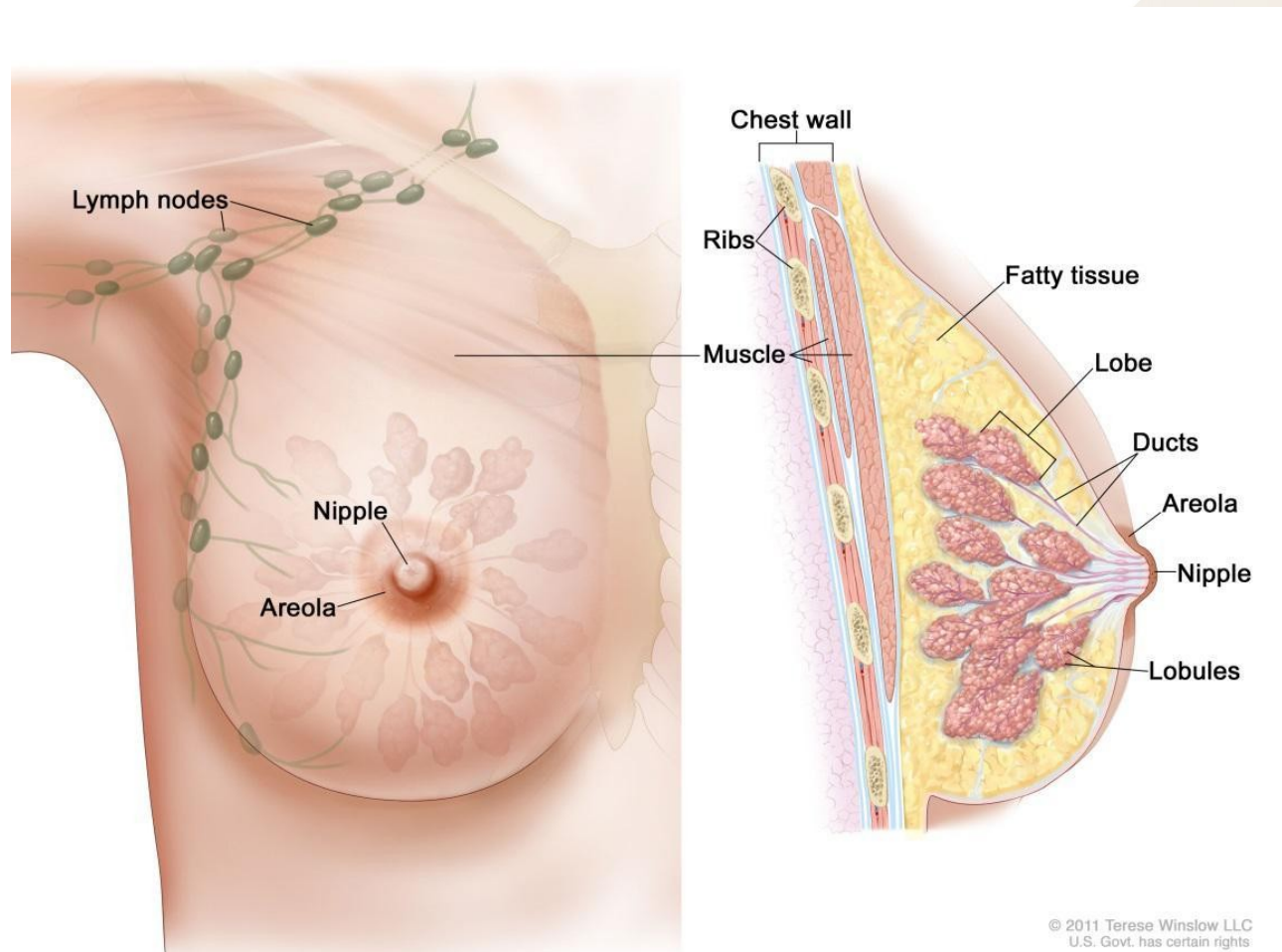


#ความรู้อำนาจ ทุกอย่างเป็นไปได้

12
RESPONSIBLE
CONSUMPTION AND
PRODUCTION



โครงสร้างและส่วนประกอบของเต้านม



โครงสร้างและส่วนประกอบของเต้านม

หัวนม (nipple)



- ยาวประมาณ 0.5–1.0 ซม.
- มีรูเปิดตรงส่วนปลาย 5–9 รู
- มีปลายประสาทสัมผัส
และเส้นเลือดจำนวนมาก
- มีกล้ามเนื้อเรียบเรียงตามแนวยาว
และรัศมี

โครงสร้างและส่วนประกอบของเต้านม

ลานนม (Areolar)

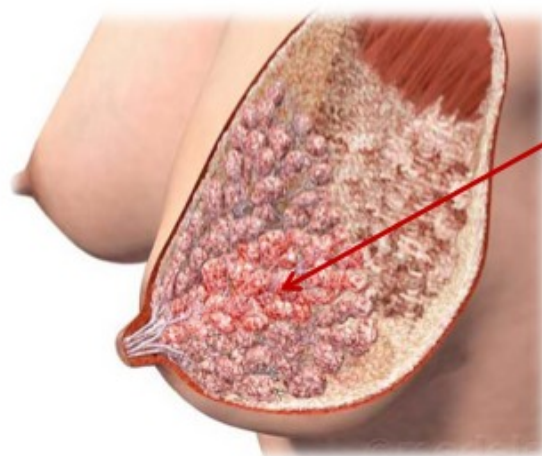


Montgomery's tubercle

มีรูเปิดของต่อมไขมันและท่อนม
ผลิตไขมันที่มีสารต้านการติดเชื้อ
และหล่อลื่นผิวหนังบริเวณลาน
นมไม่ให้แห้งและแตกง่าย

โครงสร้างและส่วนประกอบของเต้านม

ตัวเต้านม (Corpus mammae)



เนื้อเยื่อสร้างน้ำนม

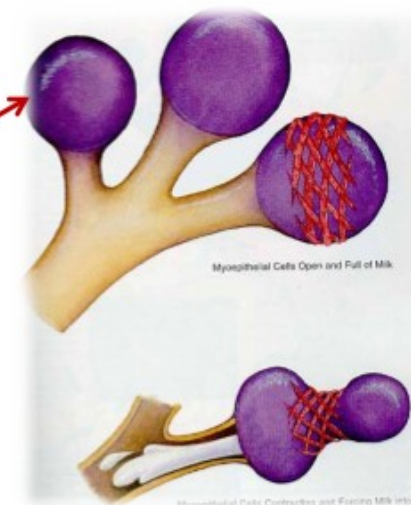
ต่อมน้ำนมจับกันเป็น lobes

เหมือนพวงองุ่น

ส่วนปลายของท่อนมฝอย

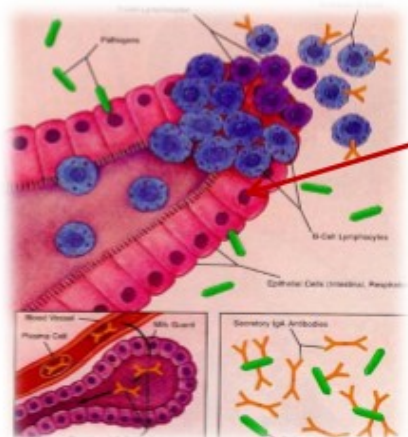
พองออกเป็นต่อมน้ำนม

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.2 มม



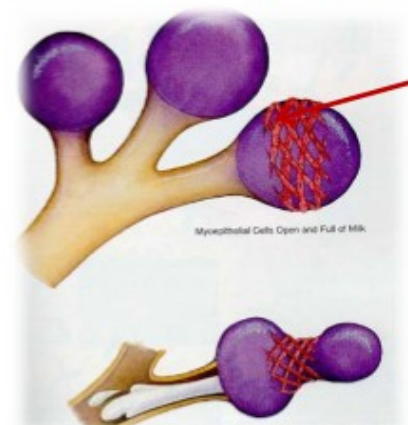
โครงสร้างและส่วนประกอบของเต้านม

ต่อมน้ำนมประกอบด้วยเซลล์ 2 ชั้น



ชั้นใน alveolar cell

ทำหน้าที่สร้างน้ำนม จากการกระตุ้นของ
ฮอร์โมน prolactin



ชั้นนอก myoepithelial cell

เรียงประสานรอบต่อมน้ำนม เมื่อได้รับ
การกระตุ้นจาก oxytocin กล้ามเนื้อหด
รัดตัว ทำให้มีการหลั่งน้ำนมออกมา

โครงสร้างและส่วนประกอบของเต้านม

ลักษณะการเรียงตัวของท่อนม

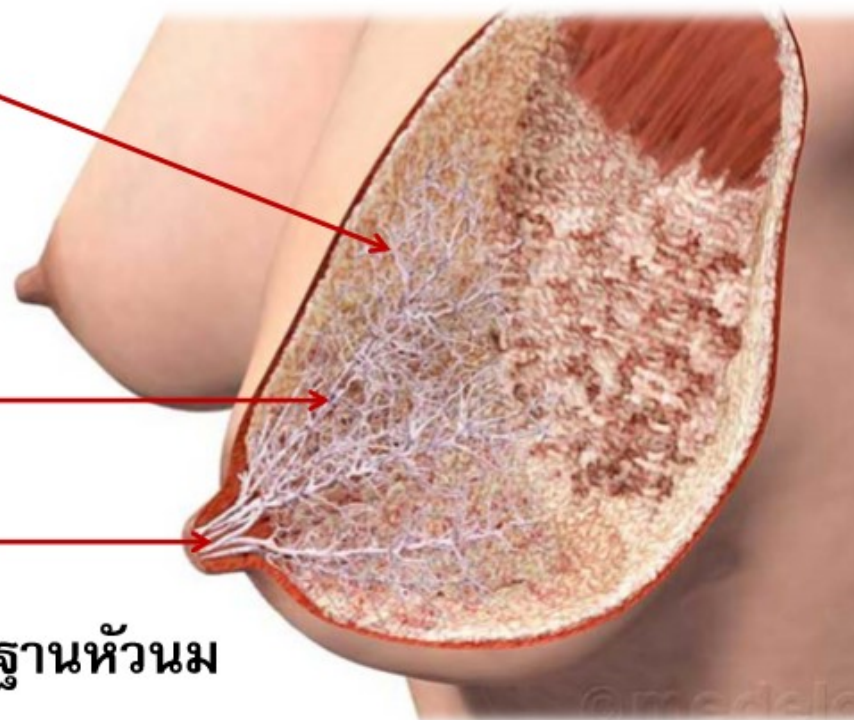
ท่อนมฝอย (ductules)

เรียงตัวเหมือนรากฝอย
ของต้นไม้

ท่อนมขนาดกลาง

ท่อนมใหญ่ (large duct)

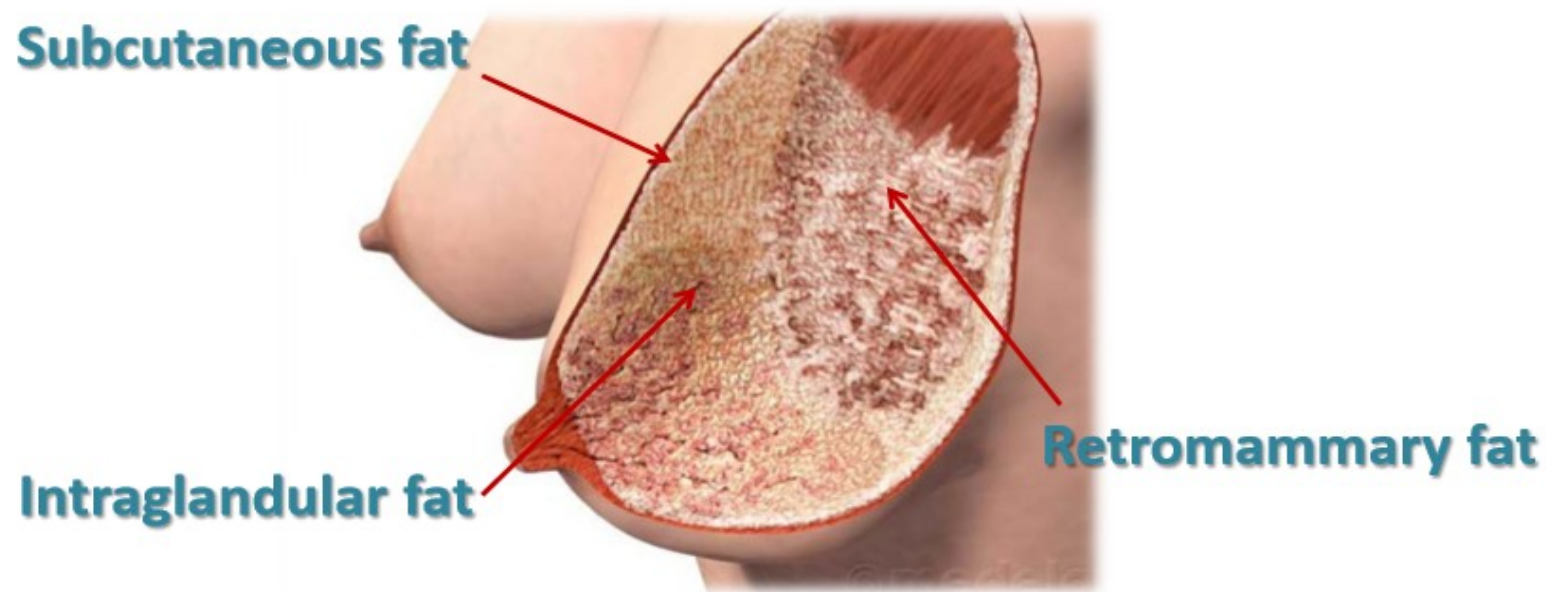
ขนาด 2-3 มม. รวมกันที่ฐานหัวนม
อยู่ตื้นทำให้ถูกกดทับได้ง่าย



©Medela AG, Switzerland, 2006.

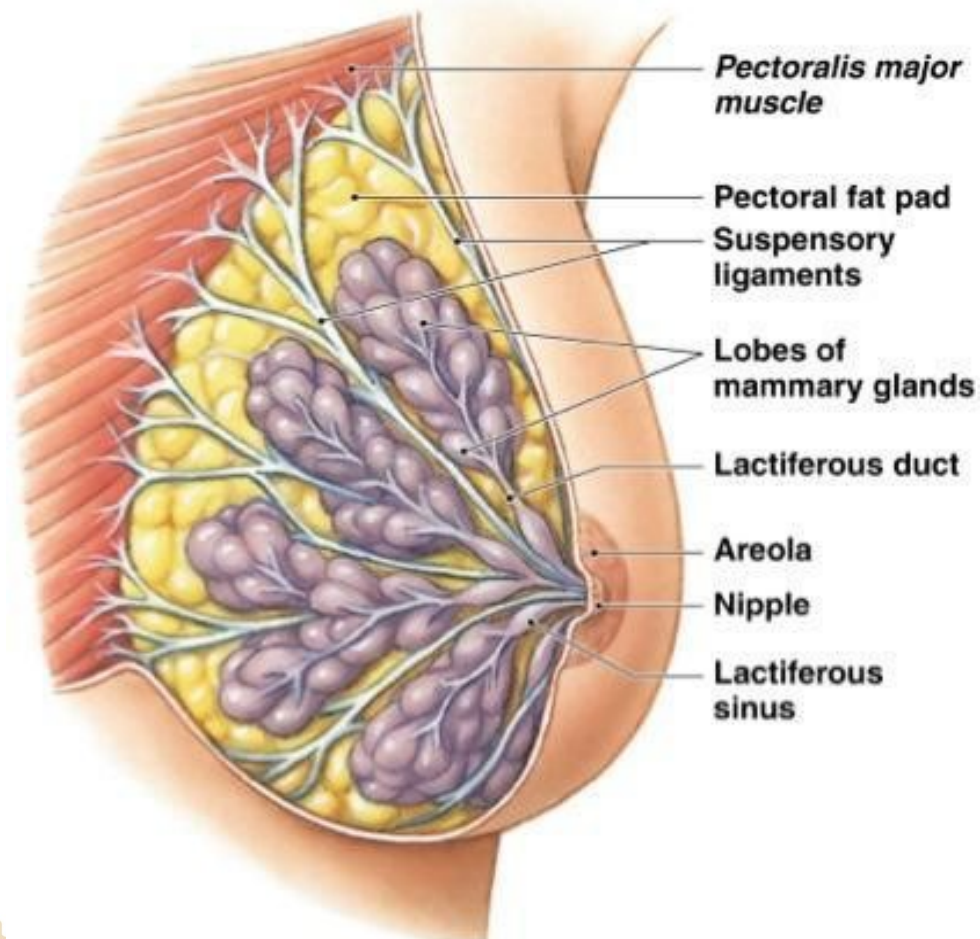
โครงสร้างและส่วนประกอบของเต้านม

การกระจายของไขมัน



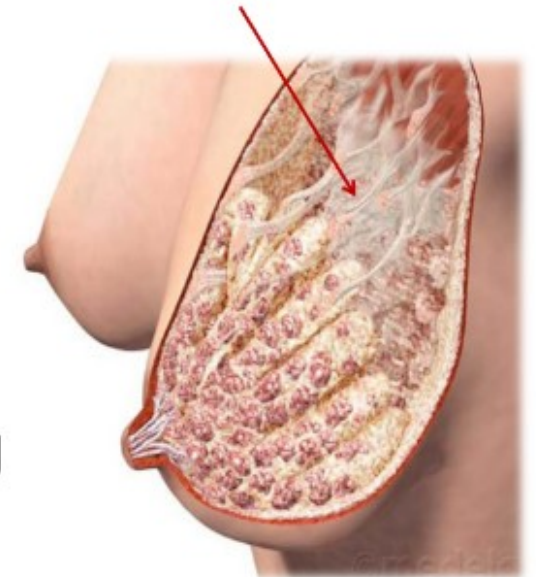
รูปร่างของเต้านมขึ้นกับปริมาณไขมัน
ไม่มีผลต่อการสร้างน้ำนม

โครงสร้างและส่วนประกอบของเต้านม



Cooper's ligament

พังผืดที่ยึดเนื้อเต้านม
จากพังผืดที่ฐาน
เต้านมไปที่ผิวหนัง
และพยุงเต้านมให้คงรูป



มะเร็งเต้านม (Breast cancer)

- เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งภายในเต้านมเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง และขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย ก่อนจะลุกลามไปสู่เนื้อเยื่อข้างเคียงและแพร่กระจายไปยังเซลล์อื่นของร่างกาย
- เซลล์มะเร็งส่วนใหญ่ที่พบมักจะเกิดขึ้นบริเวณต่อมผลิตน้ำนม (Lobules) และท่อน้ำนม (Ducts) มากกว่าส่วนอื่น การก่อตัวของมะเร็งเกิดขึ้นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป มีการแบ่งตัวมากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ จนเป็นก้อนเนื้อร้าย ก่อนจะแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง ระบบน้ำเหลือง กระแสเลือด และไปยังอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

ระยะของมะเร็งเต้านม (STAGING)

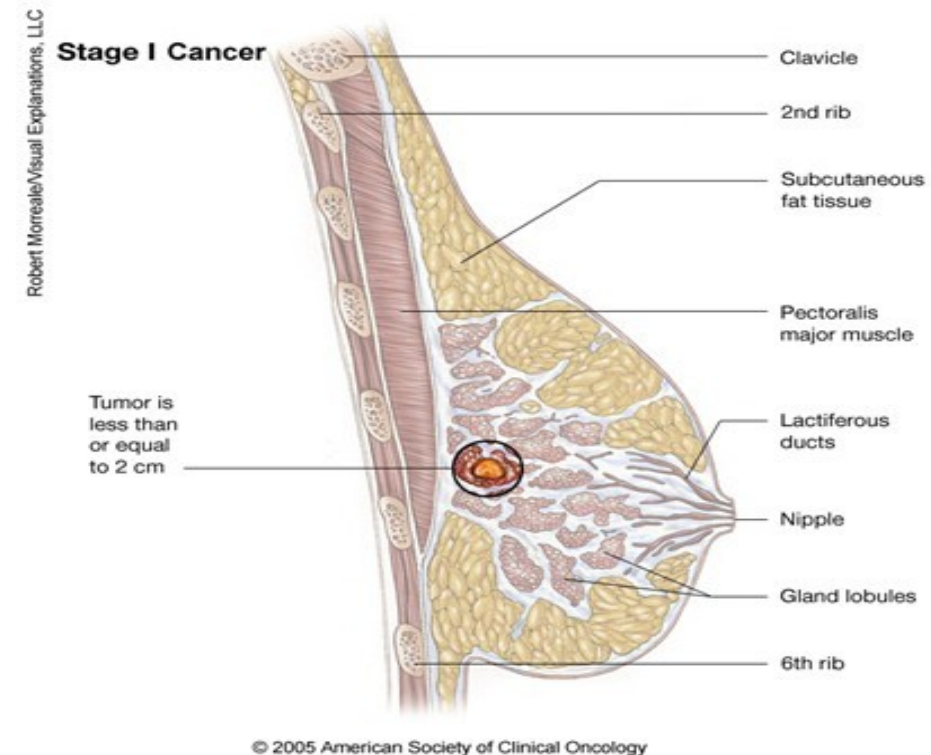
- **1. มะเร็งเต้านมระยะที่ 0 หรือ DCIS
(Ductal Carcinoma In Situ)**

เซลล์มะเร็งเพิ่งก่อตัวขึ้นจำกัดอยู่ภายในเนื้อเยื่อฐานรากยังไม่แบ่งตัวลุกลามสู่ภายนอกขอบเขต พบเซลล์ผิดปกติในเนื้อเยื่อเต้านม และก้อนเนื้อมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร แต่ยังจำกัดการเกิดเฉพาะภายในเต้านม ซึ่งเป็นระยะที่ยังไม่พบการลุกลามของโรคไปยังส่วนอื่น

ระยะของมะเร็งเต้านม (STAGING)

• 2. มะเร็งเต้านมระยะที่1

มะเร็งมีการลุกลามออกมานอกเนื้อเยื่อฐานราก แต่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปสู่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ และขนาดก้อนมะเร็งไม่เกิน 2 ซม.

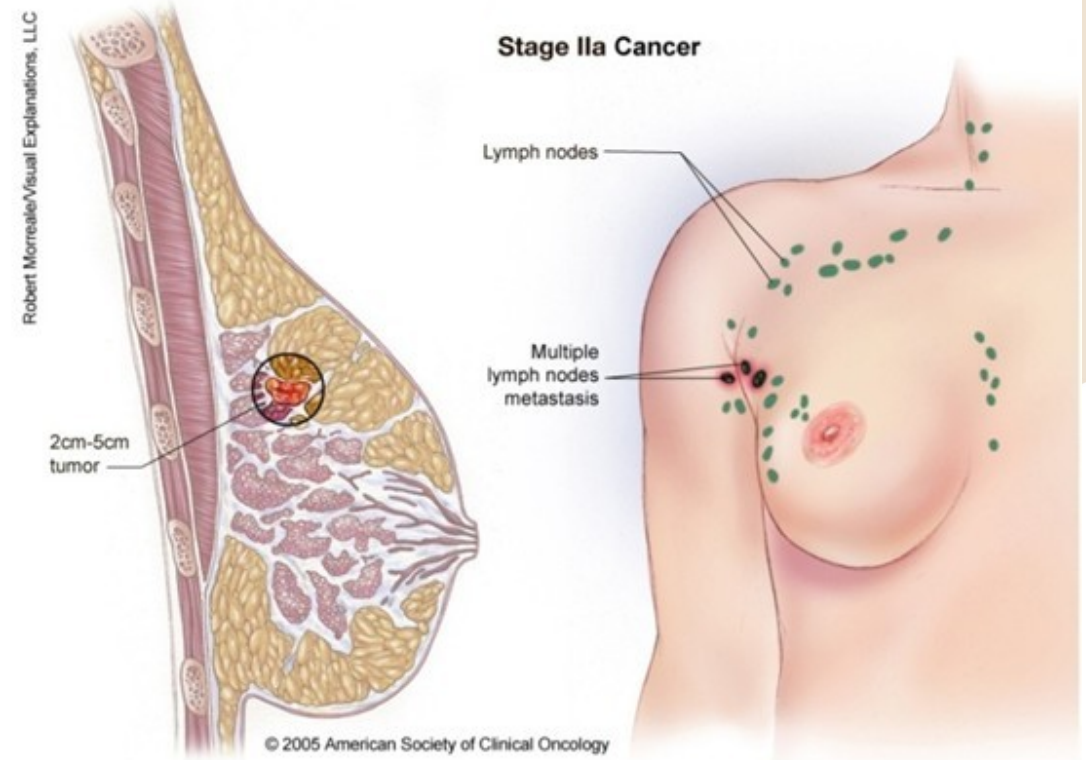


ระยะของมะเร็งเต้านม (STAGING)

• 3.มะเร็งเต้านมระยะที่ 2

- ก้อนมะเร็งขนาดเกิน 2 ซม.แต่ไม่เกิน 5 ซม.ที่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปสู่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้

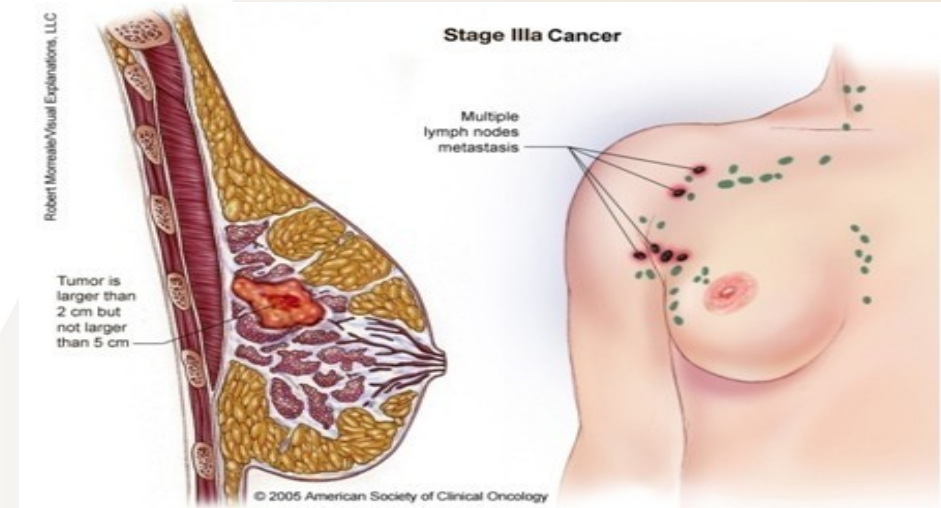
- มะเร็งขนาดเล็กไม่เกิน 2 ซม. แต่มีการแพร่กระจายไปสู่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้ว



ระยะของมะเร็งเต้านม (STAGING)

• 4.มะเร็งเต้านมระยะที่ 3

ก้อนมะเร็งขนาดใหญ่เกิน 5 ซม. หรือ
มะเร็งมีการแพร่กระจายเข้าสู่ต่อมน้ำ
เหลืองรักแร้จำนวนหลายต่อมทั่วไปหมด



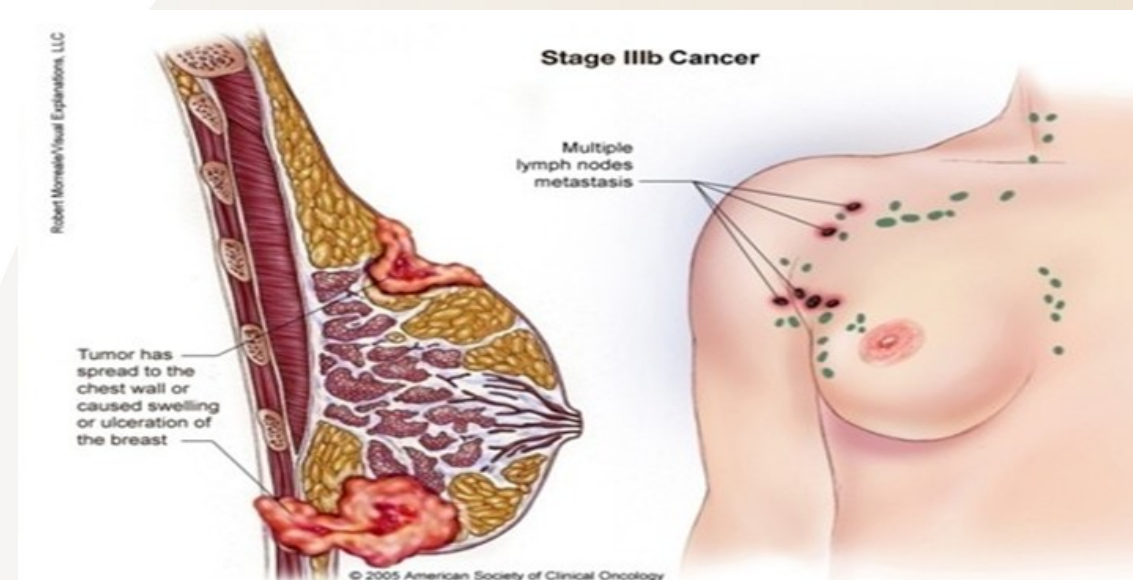
แสดงมะเร็งเต้านมระยะที่ 3A

- ไม่มีก้อนที่เต้านม แต่มีมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้
- เนื้องอกมีขนาดเล็กกว่า 5 ซม.และมีการแพร่ไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ที่อยู่ใกล้
- เนื้องอกมีขนาดใหญ่กว่า 5 ซม.และแพร่ไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ที่อยู่ใกล้

• มะเร็งเต้านมระยะที่ 3

แสดงมะเร็งเต้านมระยะที่ 3B

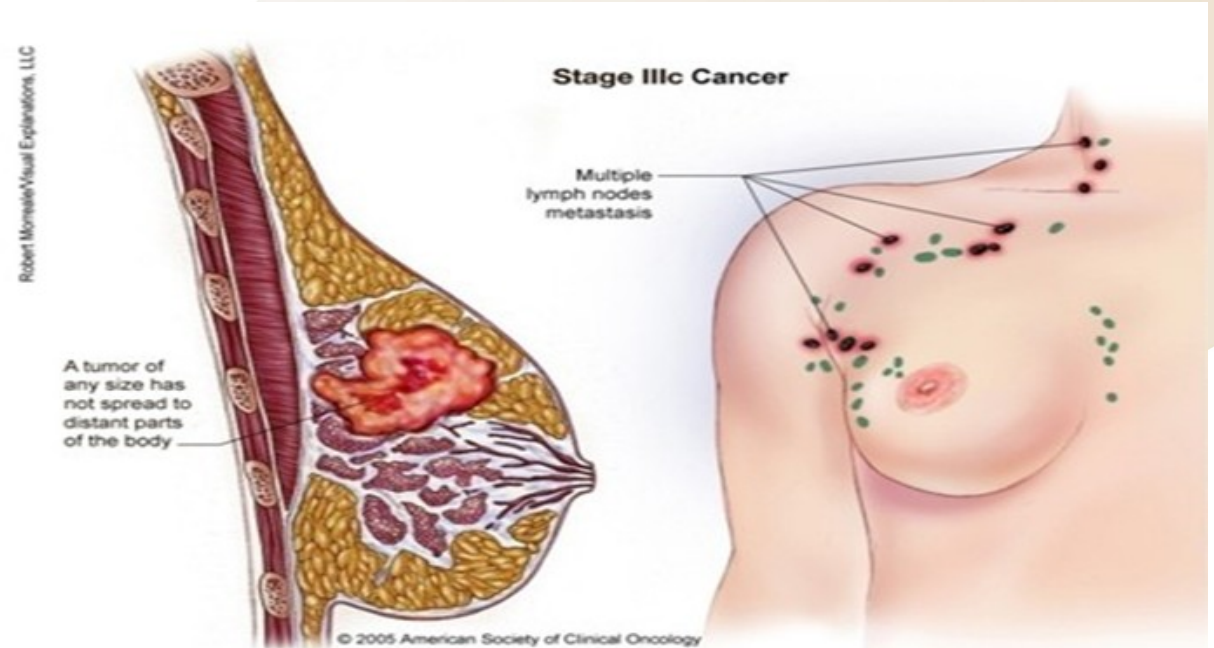
- ก้อนมะเร็งมีขนาดเท่าไรก็ได้
- เนื้องอกมีการแพร่ไปยังอวัยวะใกล้เคียง เช่น กล้ามเนื้อหรือผิวหนัง



• มะเร็งเต้านมระยะที่ 3

แสดงมะเร็งเต้านมระยะที่ 3C

- มะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่คอ
- มะเร็งแพร่ไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียง หรือ ต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้

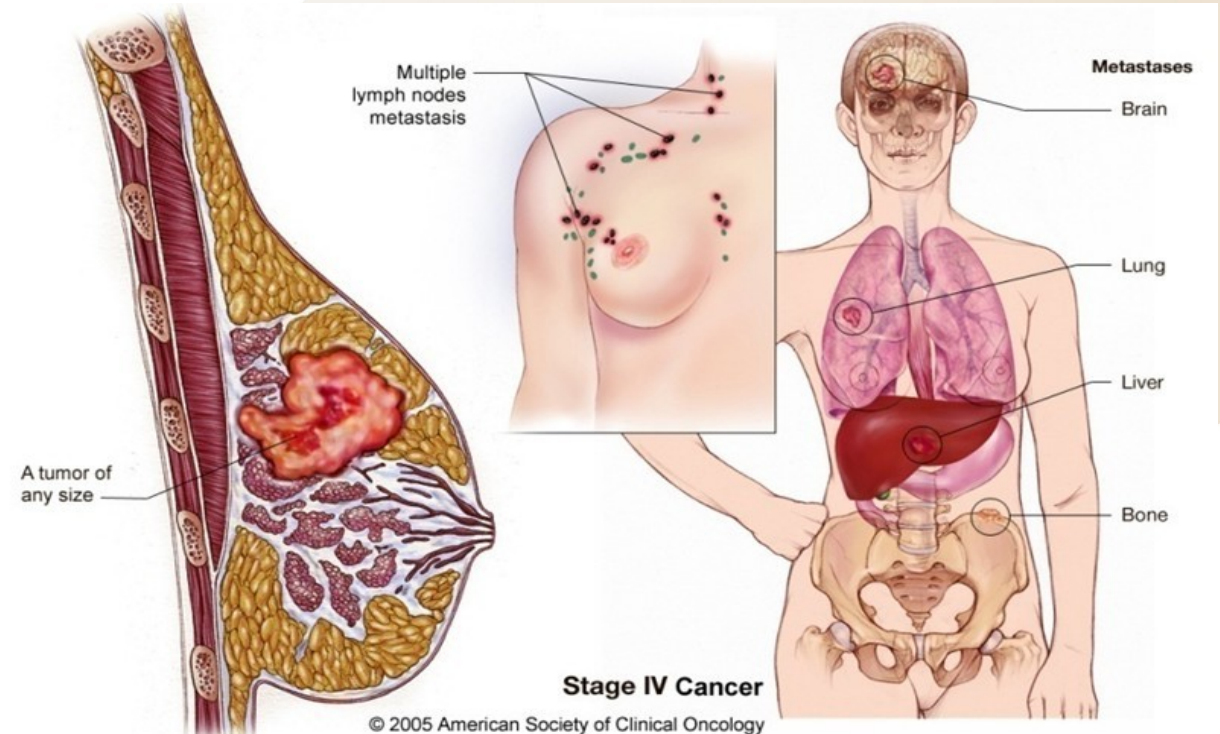


ระยะของมะเร็งเต้านม (STAGING)

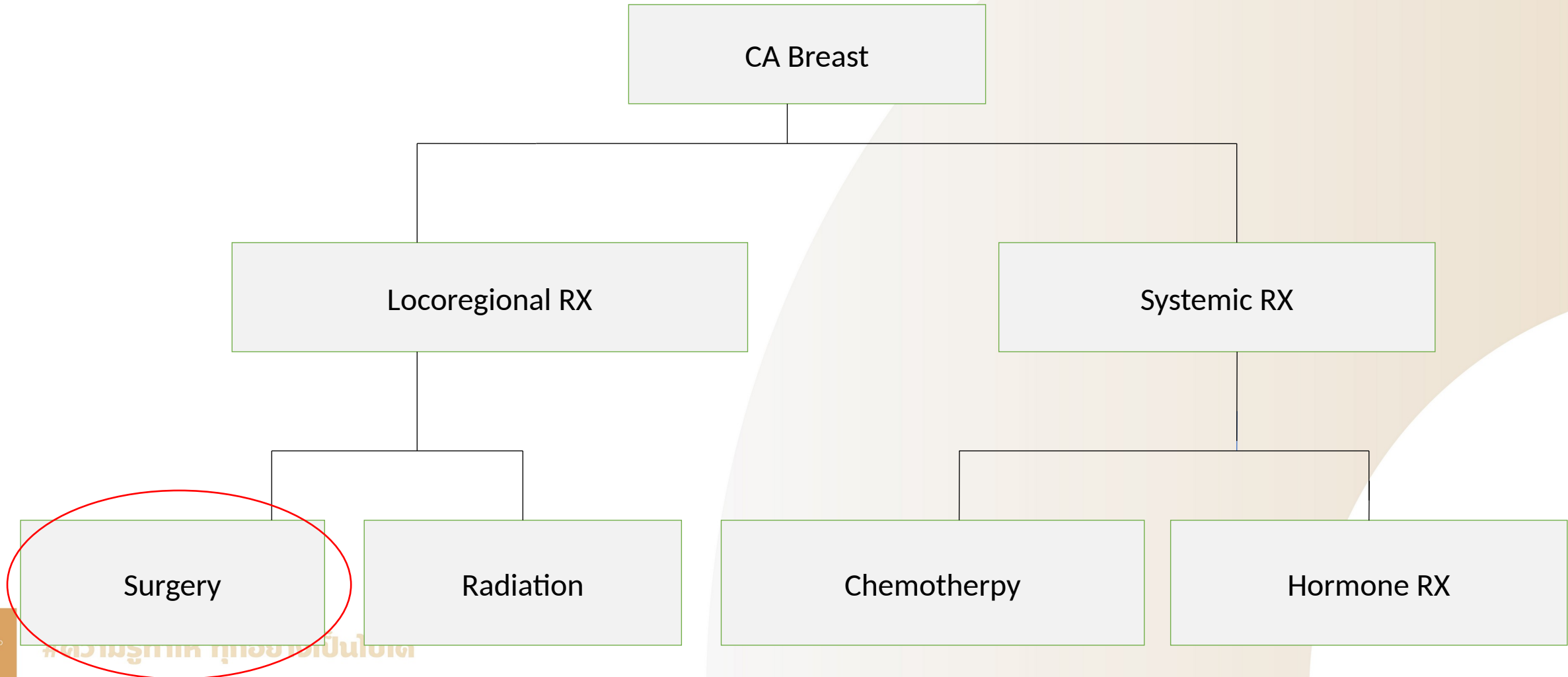
- 5.มะเร็งเต้านมระยะที่ 4

เป็นระยะสุดท้ายคือมะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด กระดูก ตับ สมอง เป็นต้น

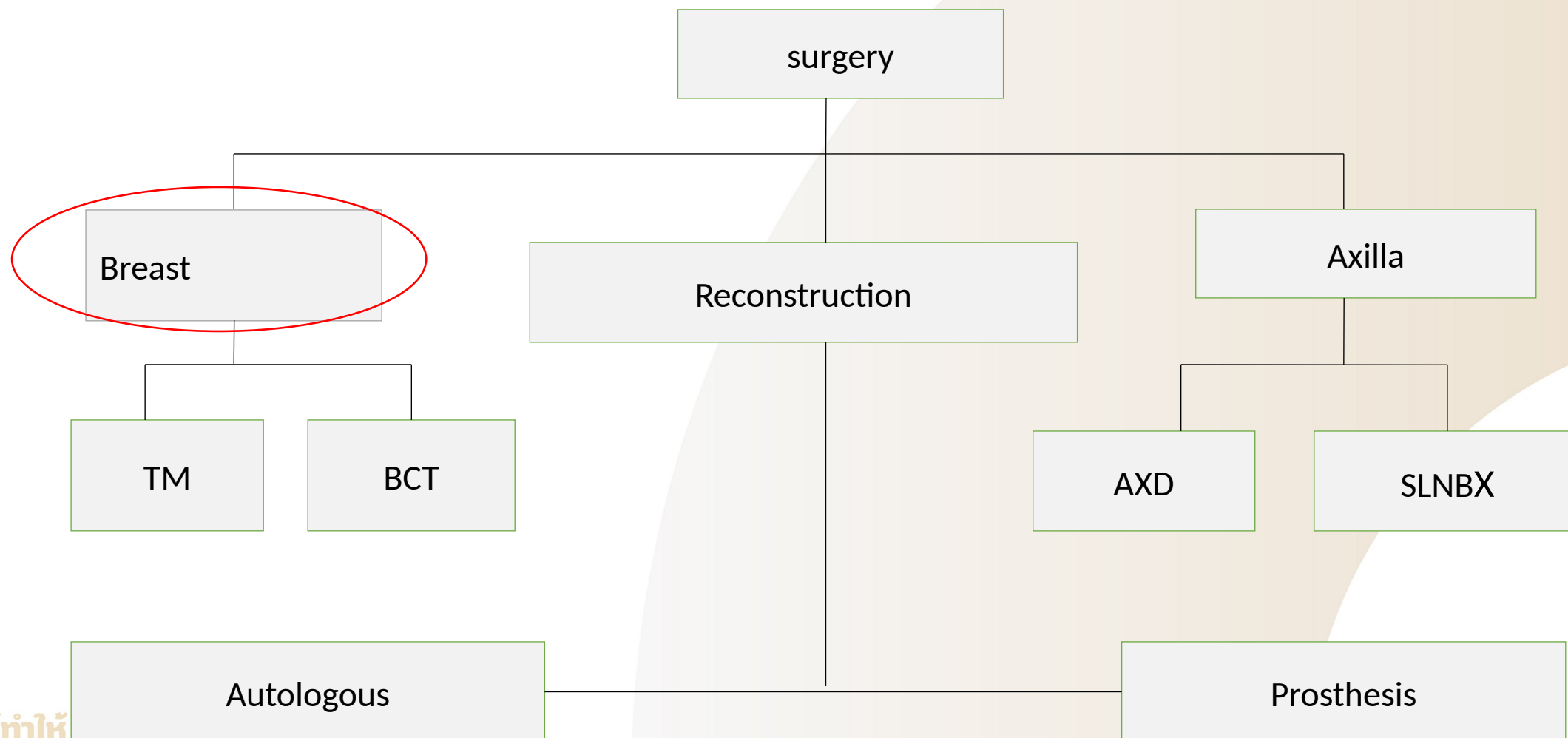
Robert Morreale/Visual Explanations, LLC



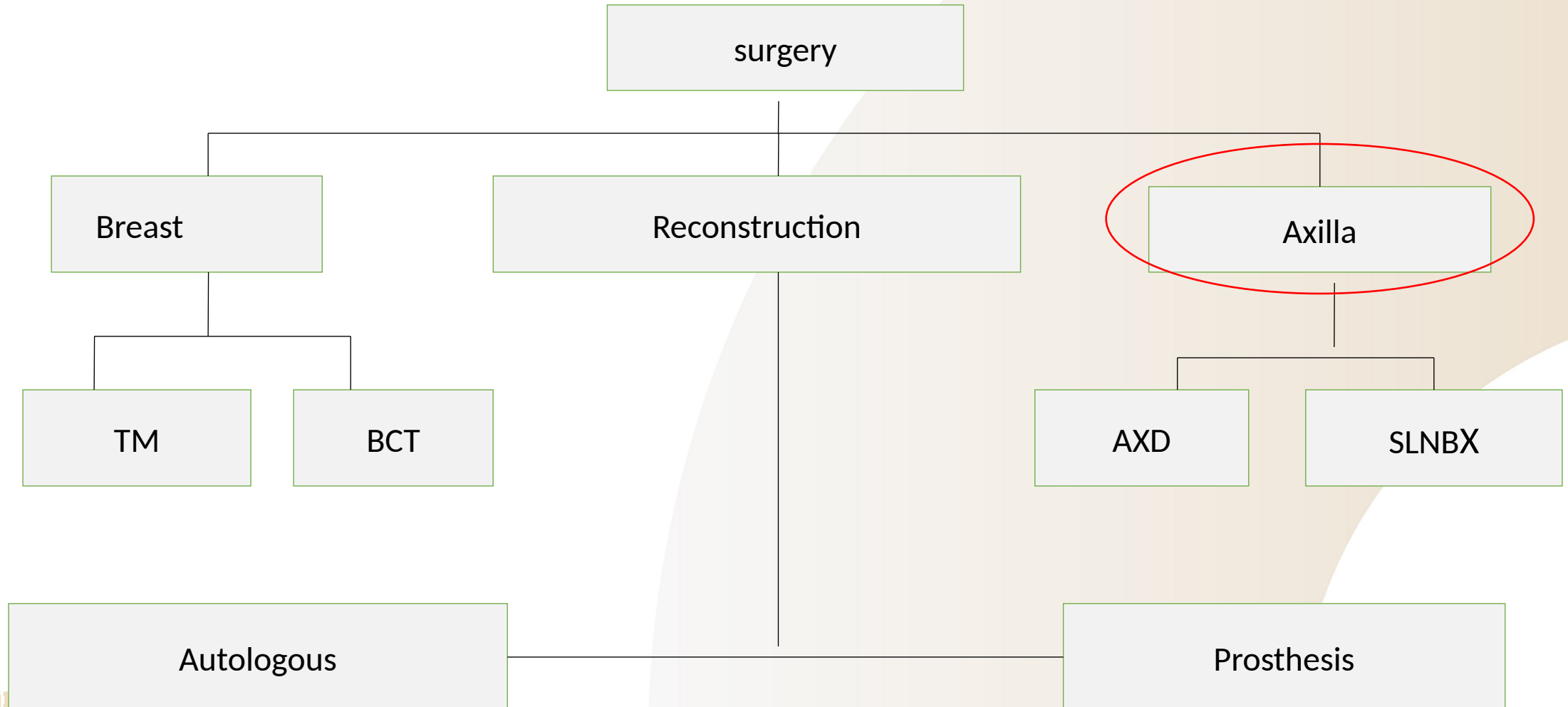
Treatment of breast cancer



Treatment of breast cancer

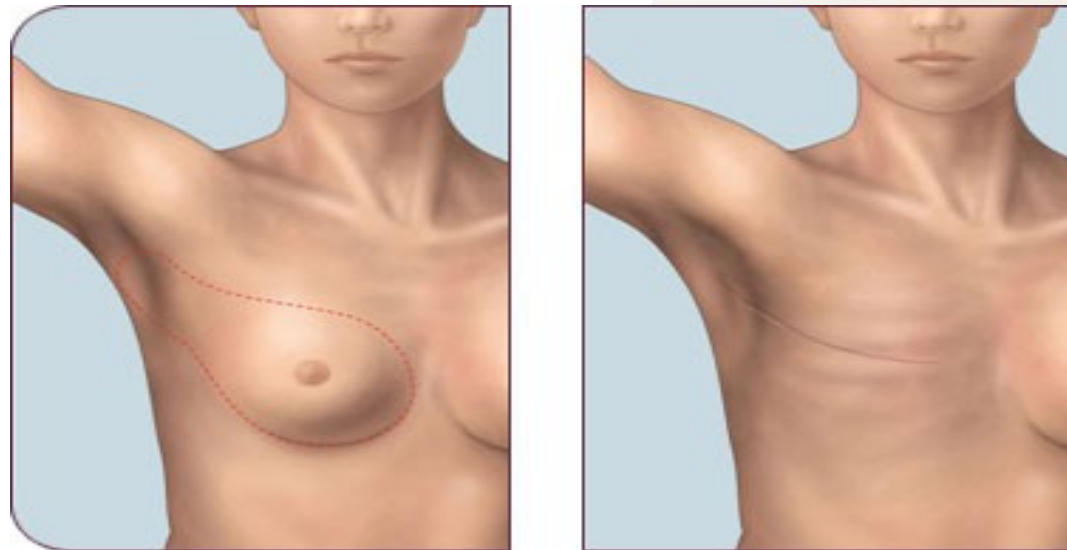


Treatment of breast cancer



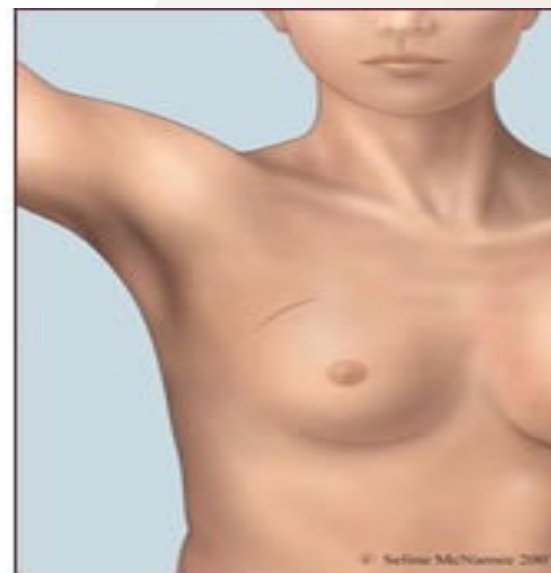
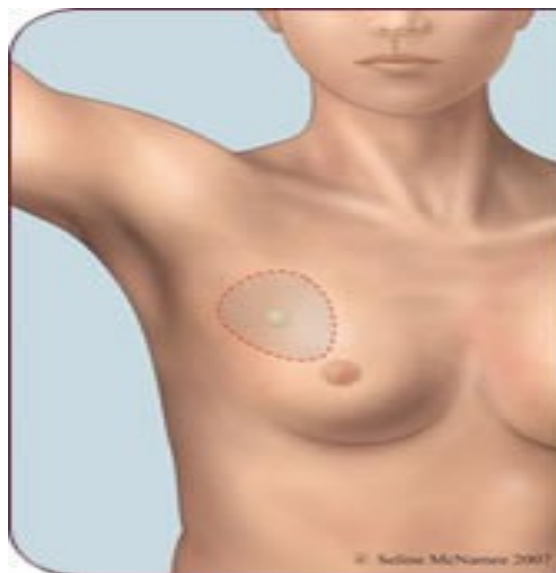
Breast surgery

- ▮ Total mastectomy การตัดเต้านมออกทั้งเต้า (รวมผิวหนังส่วนที่อยู่เหนือหัวนมและหัวนมด้วย)



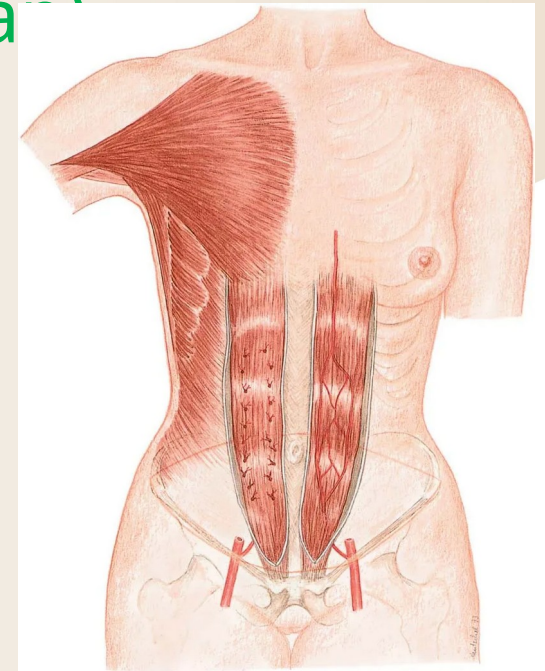
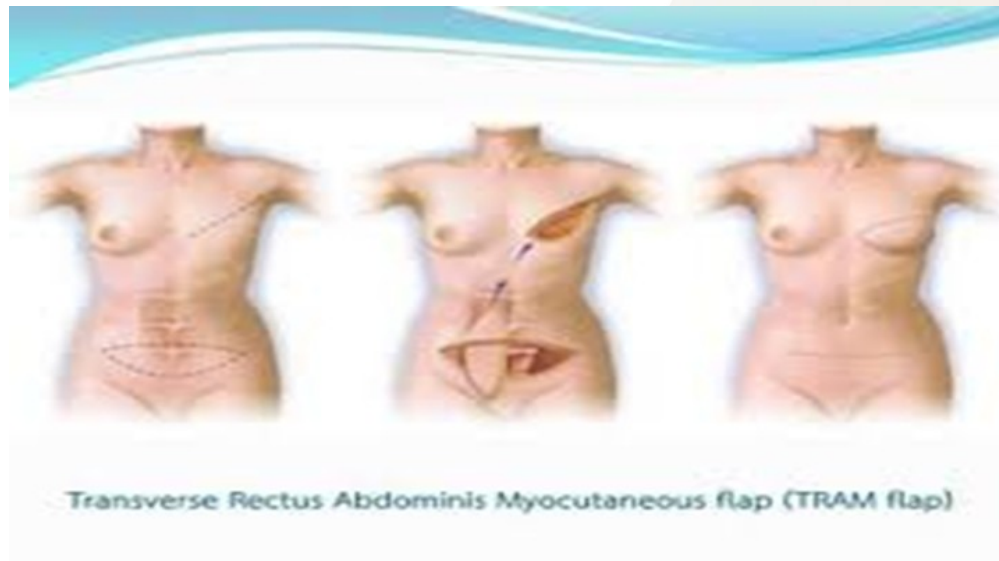
Breast surgery

- □ Breast conserving therapy การตัดเต้านมออกเพียงบางส่วน โดยตัดห่างจากขอบของก้อนมะเร็งประมาณ 1-2 ซม. โดยมากจะยังคงเหลือหัวนม ฐานหัวนมและส่วนใหญ่ของเนื้อเต้านม



Breast surgery

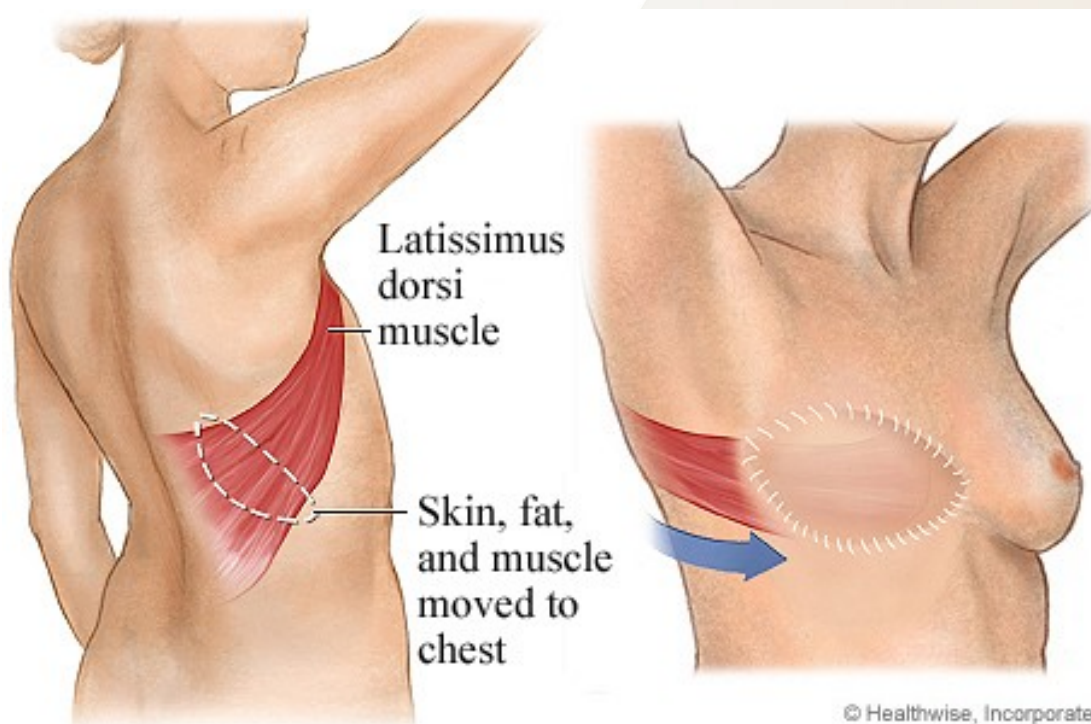
- **การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม (Breast reconstruction)**
ได้แก่
 - การผ่าตัดนำผิวหนัง เนื้อเยื่อไขมันและกล้ามเนื้อหน้าท้อง (Transverse rectus abdominis myocutaneous flap or TRAM flap)



#ความรู้ทำให้ ทุกอย่างเป็นไปได้

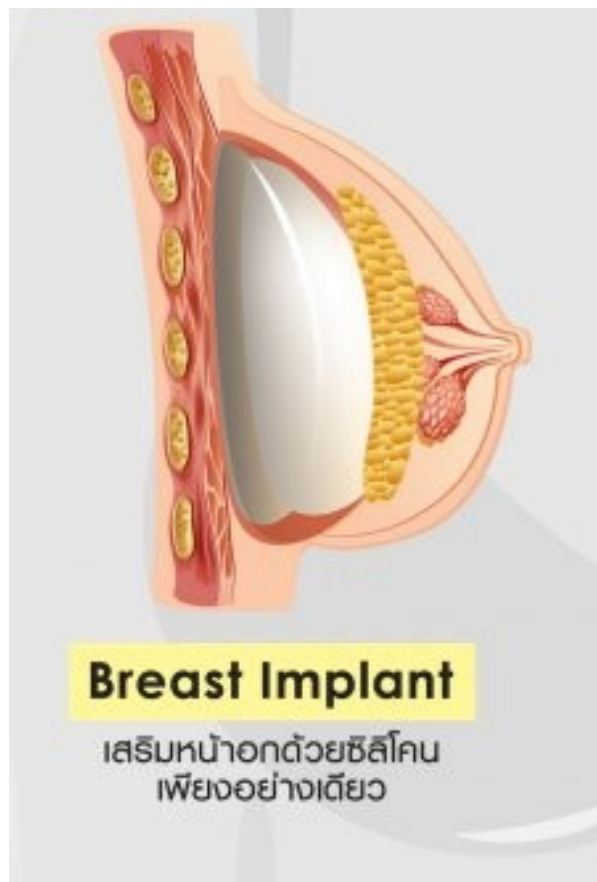
การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม (Breast reconstruction)

- การผ่าตัดนำผิวหนัง เนื้อเยื่อไขมันและกล้ามเนื้อบริเวณสะบัก (Latissimus dorsi myofascial flap or LD flap)



การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม (Breast reconstruction)

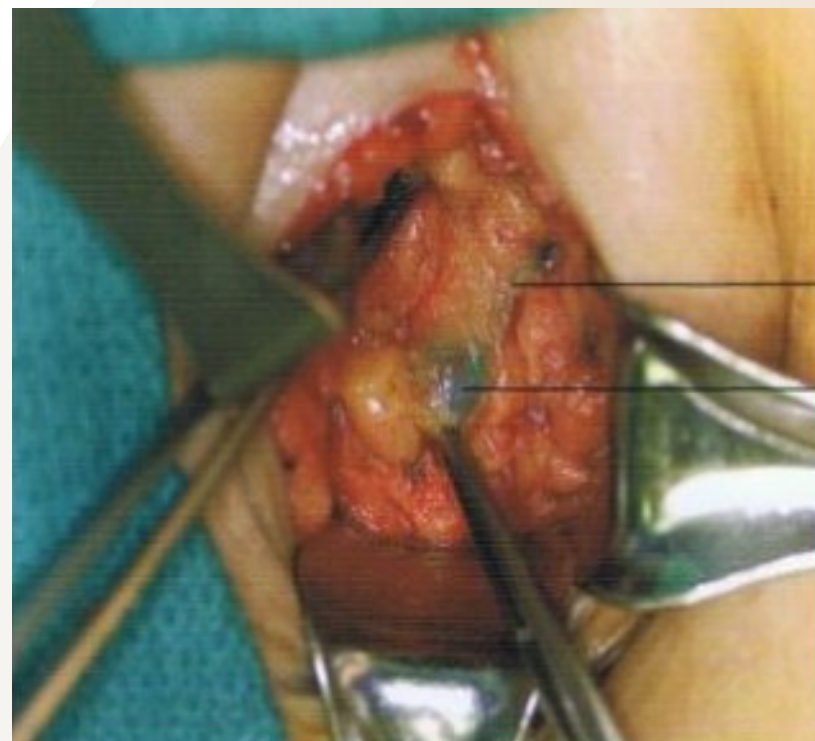
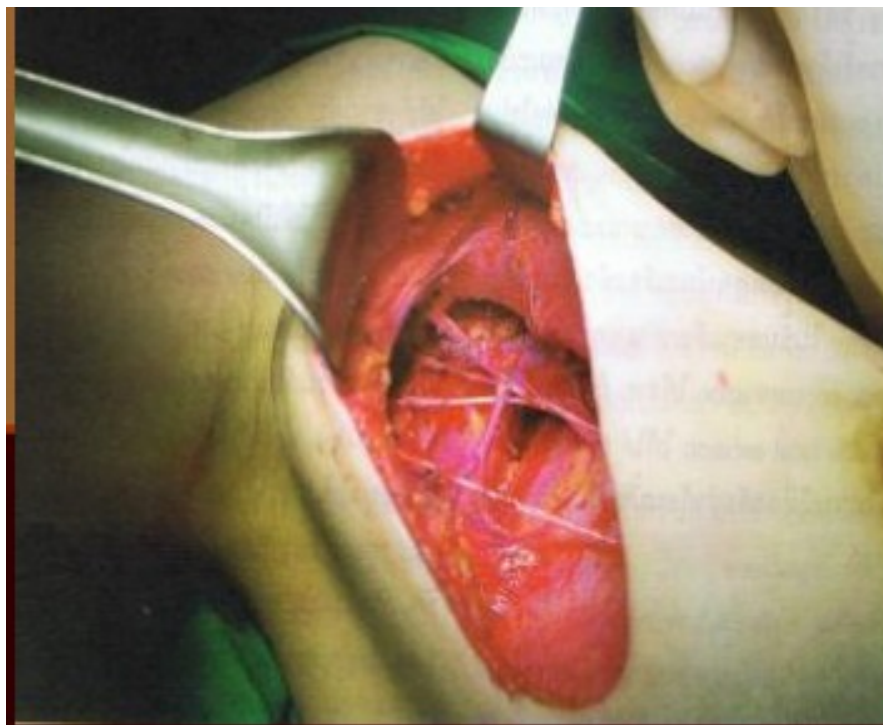
- การผ่าตัดเพื่อใส่เต้านมเทียม (Prosthesis)



Axillary staging

▣ Axillary dissection

▣ Sentinel LN biopsy



Technique in SLNB



blue dye technique
radioisotope technique
combined technique



#ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้

STEP IN SLNB

Blue Dye injection at peritumoural area

Gentle massage 5 minute

Axillary incision at lowest hairline

Identify lymphatic tract

Tracing to Sentinel node

Removed Sentinel node and sent for frozen section

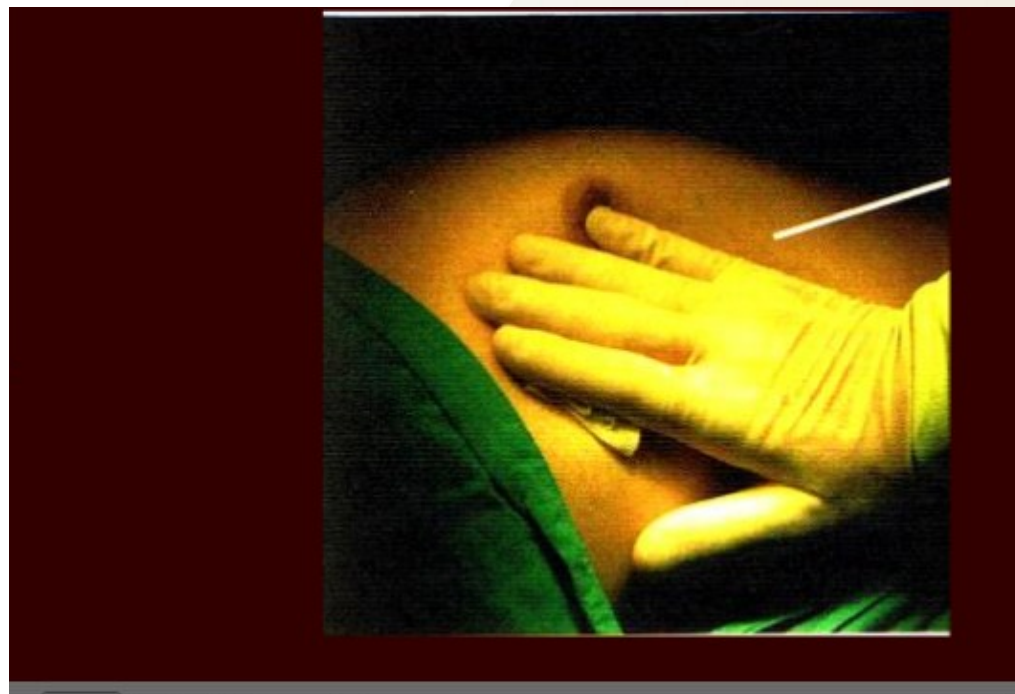
Step in SLNB

1. Blue Dye injection at peritumoral area



Step in SLNB

2. Gentle massage 5 minute



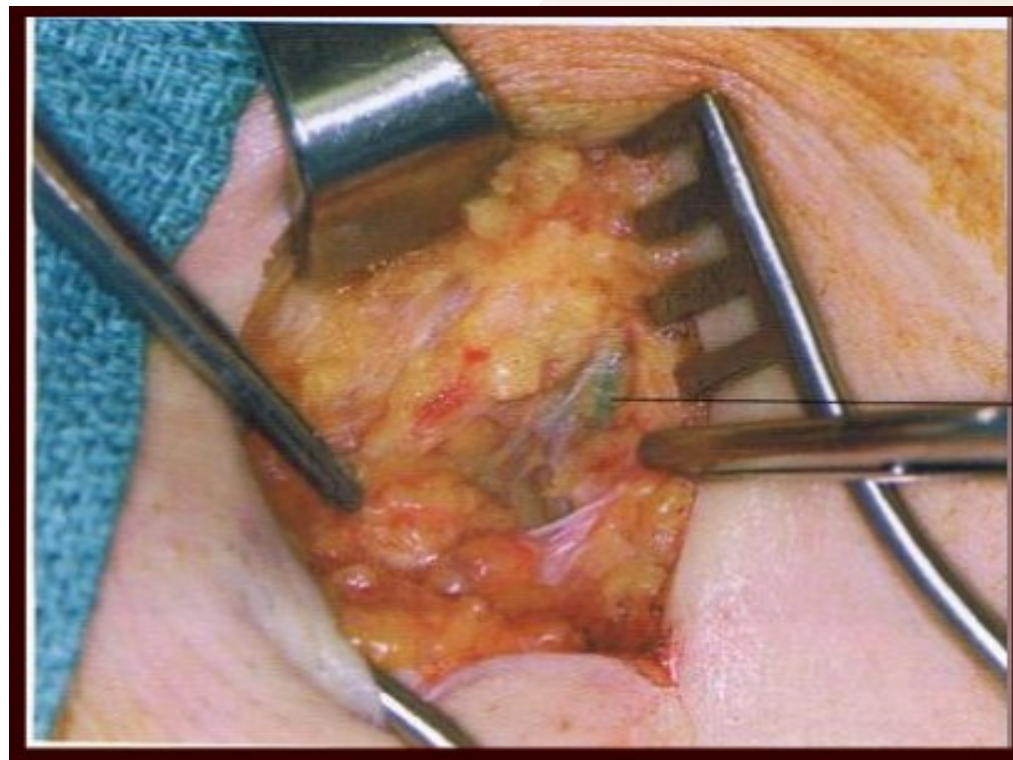
Step in SLNB

3. Axillary incision at lowest hairline



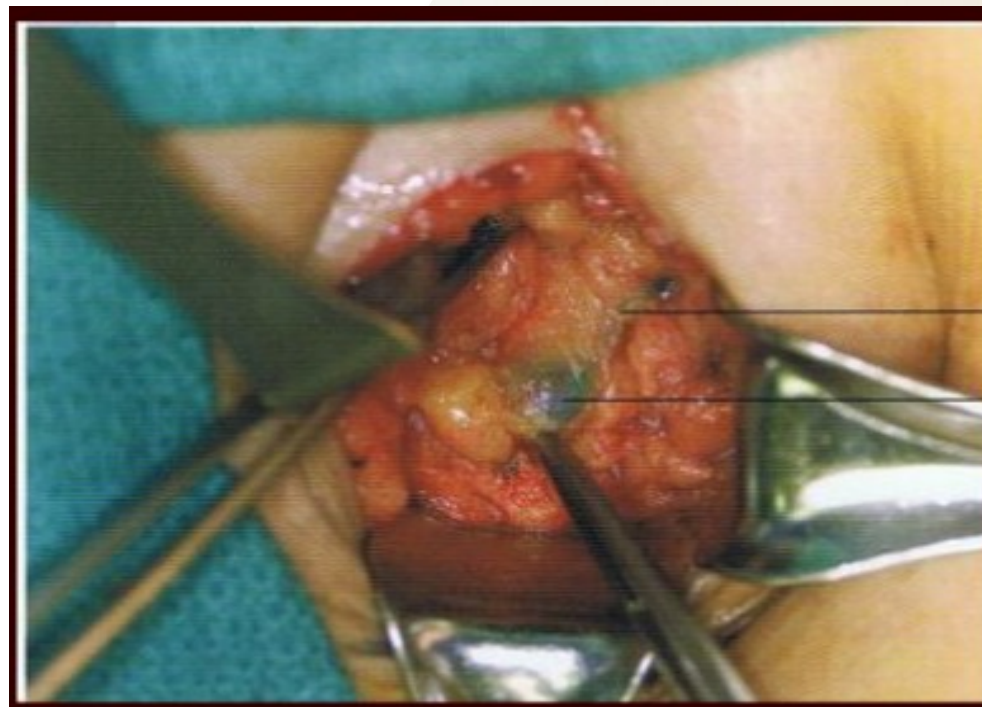
Step in SLNB

4. Identify lymphatic tract



Step in SLNB

5. Tracing to sentinel node



Step in SLNB

6. Removed sentinel node and sent for frozen section



การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลในระยะผ่าตัด

- การจัดทำสำหรับการผ่าตัด

ท่านอนหงาย (supine position) กางแขนทั้ง 2 ข้าง แต่ละข้างกางไม่เกิน 90 องศา เนื่องจากการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล จะทำผ่าตัดบริเวณหน้าอกของผู้ป่วย

การจัดทำสำหรับการผ่าตัด

- อุปกรณ์จัดทำ

Doughnut รองใต้ศีรษะ

หมอนทราย รองข้างลำตัวด้านตรงข้ามที่ทำ
ผ่าตัด

Jelly ยาวสี่เหลี่ยมรองข้างลำตัวด้านที่ทำผ่าตัด

Jelly สี่ฟ้า รองแขนรองใต้แขนข้างที่ทำผ่าตัด

Bair hugger Warm ผู้ป่วยตั้งแต่บริเวณเหนือ
สะดือ 2 ซ.ม. จนถึงปลายเท้า

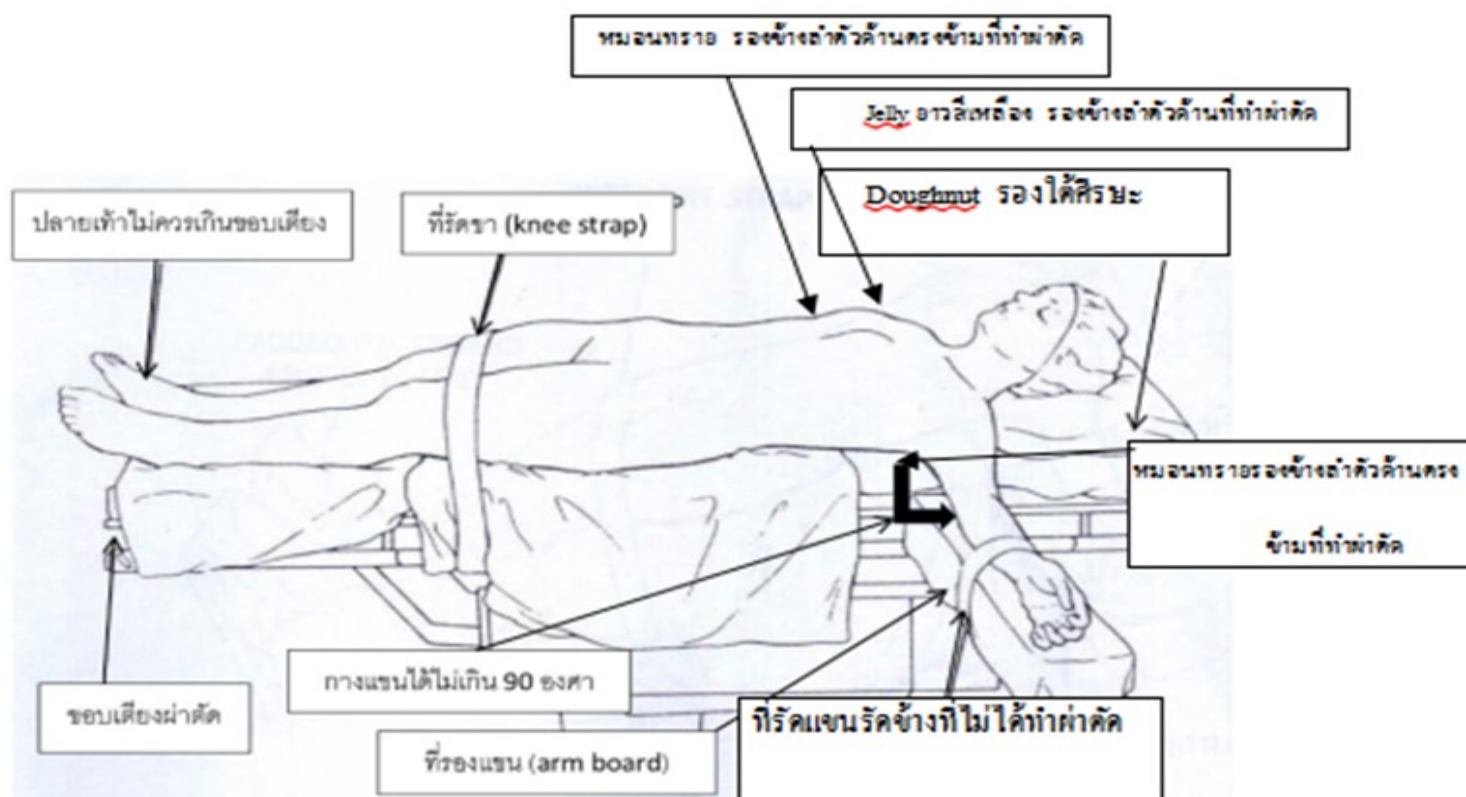
ที่รัดขาผู้ป่วย knee strap

ที่รองแขน (arm board) รองแขนทั้ง 2 ข้าง
รวมกับที่รัดแขน(รัด
แขนข้างที่ไม่ได้ทำ



#ความรู้นำทำให้ ทุกอย่างเป็นไปได้ ผ่าตัด)

การจัดท่าสำหรับการผ่าตัด



การจัดท่าสำหรับการผ่าตัด



Instrument & Supply & Suture Materials

- **Set ผ้า :**

1. Ordinary set 1 pack
2. Surgical Gown 1 pack
3. Basin set 1 pack
4. Sheet 2*2 2 pack
5. ผ้าสีเหลี่ยม 3 pack

- **Set เครื่องมือ :** Basic set Head Neck



Instrument & Supply & Suture Materials

- supply ต่างๆ



#ความรู้นำไปใช้ ทุกอย่างเป็นไปได้

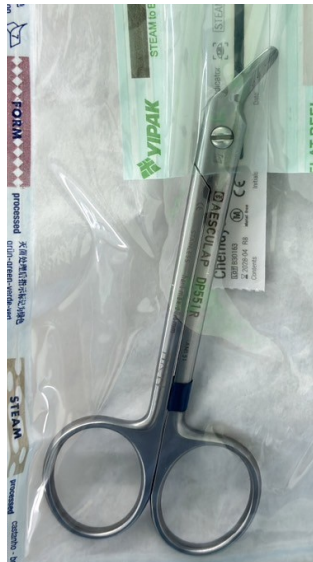
Instrument & Supply & Suture Materials

- น้ำยาต่างๆ
 - 2% chlorhexidine in 70% alcohol
 - 0.9% Normal saline
 - Boney blue



Breast Conservative Therapy

- Needle localization คือ การใช้สายลวดนำทางเข้าไปวางตำแหน่งของก้อน เพื่อให้ทราบตำแหน่งขณะผ่าตัด
- เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพิ่ม



#ความรู้นำพาให้ ทุกอย่างเป็นไปได้

การจัดท่าสำหรับการผ่าตัด



Instrument & Supply & Suture Materials

- **Set ผ้า :**

1. Ordinary set 1 pack
2. Surgical Gown 1 pack
3. Basin set 1 pack
4. Sheet 2*2 2 pack
5. ผ้าสีเหลี่ยม 3 pack

- **Set เครื่องมือ :** Basic set Head Neck



Instrument & Supply & Suture Materials

- supply ต่างๆ



#ความรู้นำไปใช้ ทุกอย่างเป็นไปได้

Instrument & Supply & Suture Materials

- น้ำยาต่างๆ
 - 2% chlorhexidine in 70% alcohol
 - 0.9% Normal saline
 - Boney blue



การผ่าตัดเสริมเต้านมโดยใช้อวัยวะของผู้ป่วยเอง

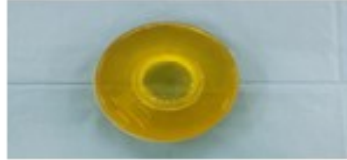
- **TRAM FLAP COVERAGE**

(Transverse Rectus Abdominis Muscle Flap coverage)

- **LD FLAP COVERAGE**

(Latissimus Dorsi Flap Coverage)

การจัดทำ TRAM FLAP COVERAGE



รูปที่ 1 Donut Jelly สำหรับรองศีรษะ



รูปที่ 2 Jelly ลักษณะลาดเอียงสำหรับหนุนศีรษะ



รูปที่ 3 หมอน Jelly ขาวมีร่องตรงกลางสำหรับรองศีรษะ



รูปที่ 4 หมอนทรายสำหรับดันข้างลำตัว



รูปที่ 5 หมอนใบใหญ่สำหรับรองศีรษะ



รูปที่ 6 หมอนใบเล็กสำหรับรองศีรษะ



การจัดท่า TRAM FLAP COVERAGE



เครื่องมือพิเศษที่ต้องเตรียมเพิ่ม



Instrument & Supply & Suture Materials

- supply ต่างๆ
เพิ่มขึ้นอย่างละ 2 ชุด



#ความรู้นำพาให้ ทุกอย่างเป็นไปได้

Instrument & Supply & Suture Materials

- น้ำยาต่างๆ
 - 2% chlorhexidine in 70% alcohol
 - 0.9% Normal saline
 - Boney blue
 - ชุดสวนปัสสาวะ



การจัดทำ LD FLAP COVERAGE



รูปที่ 1 Donut jelly สำหรับตรึงศีรษะ



รูปที่ 2 หมอน jelly ทรงสูงสำหรับตรึงศีรษะและลำตัว



รูปที่ 3 หมอน Jelly ทรงสูงสำหรับตรึงศีรษะและลำตัว



รูปที่ 7 หมอนยางสำหรับตรึงศีรษะ



รูปที่ 4 หมอนทรงสูงสำหรับตรึงศีรษะ



รูปที่ 5 หมอน Jelly ทรงสูงสำหรับตรึงศีรษะและลำตัว



รูปที่ 6 BCrane Armature สำหรับตรึงศีรษะและลำตัว



การจัดท่า LD FLAP COVERAGE



การจัดท่า LD FLAP COVERAGE



เครื่องมือพิเศษที่ต้องเตรียมเพิ่ม



Instrument & Supply & Suture Materials

- supply ต่างๆ
เพิ่มขึ้นอย่างละ 2 ชุด



#ความรู้นำพาให้ ทุกอย่างเป็นไปได้

Instrument & Supply & Suture Materials

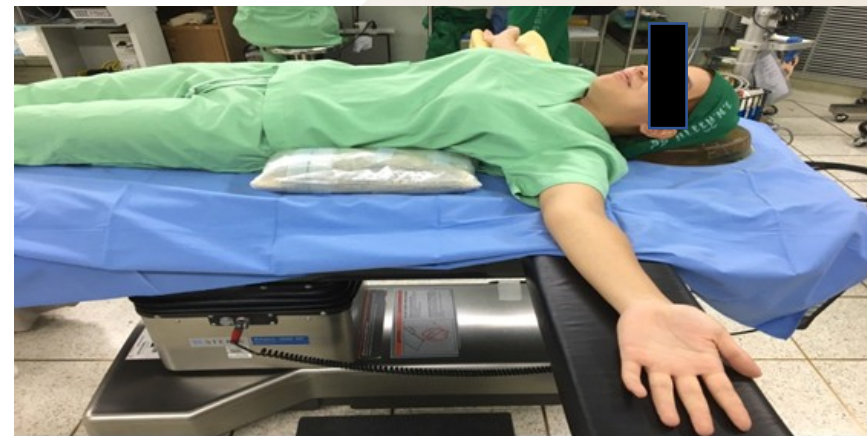
- น้ำยาต่างๆ
 - 2% chlorhexidine in 70% alcohol
 - 0.9% Normal saline
 - Boney blue
 - ชุดสวนปัสสาวะ (แล้วแต่ศัลยแพทย์)



การผ่าตัดเสริมเต้านมโดยใช้อวัยวะเทียม (Prosthesis)



การจัดท่าสำหรับการผ่าตัด



หลังจากที่ผ่าตัด NSM With SLNBx แล้ว จะเอาอุปกรณ์จัดท่าออก
หมด เพื่อทำผ่าตัด
เสริมหน้าอกด้วย Prosthesis ในขั้นตอนต่อไป
ผู้ป่วยจะนอนในท่า Supine Position หนุนศีรษะ ด้วย Jelly หนุน
ศีรษะ อย่างเดียว

เครื่องมือพิเศษที่ต้องเตรียมเพิ่ม



ชาปลายมือหลังผ่าตัดหรือ กล้ามเนื้อบริเวณสะบักอ่อนแรง

- การผ่าตัดควรหาเส้นประสาทที่สำคัญบริเวณนี้ เช่น Long thoracic n. (เป็นเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ Serratus Anterior) ทำให้เกิดอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณสะบักหลังผ่าตัด
- Thoracodorsal n. (เลี้ยงกล้ามเนื้อ Latissimus Dorsi) เพื่อป้องกันการทำงานของข้อไหล่ผิดปกติ การบาดเจ็บต่อ
- Brachial plexus จะมีอาการรู้สึกชาๆ ที่นิ้วจนถึงอ่อนแรงและชาทั้งแขน จะหายเป็นปกติ แต่อาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์
- Axillary vein และ Axillary artery ถ้ามีการฉีกขาดก็ควรจะซ่อมแซม

ภาวะแทรกซ้อนจากการจัดทำ : Brachial Plexus Nerve Injury

- การพยาบาล
 - Observe ความผิดปกติของการหายใจ การเคลื่อนไหวของแขน และความผิดปกติของสะบัก
 - ติดตามอาการแสดงเปรียบเทียบแขน สอง ข้าง
 - ซิพจรบริเวณข้อมือ
 - รู้สึกชา หรือรู้สึกเหมือนมีของแหลมทิ่มที่มือ
 - เวลาที่เลือดไหลมาเต็มเส้นเลือดฝอยใช้เวลามากกว่า 3 วินาที
 - ซีดเขียว ปลายมือเย็น
 - ไม่สามารถงอหรือเหยียดนิ้วได้

ภาวะแทรกซ้อนจากการจัดทำ : Deep Vein Trombosis

- ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการ
- อาการแสดง : การมีแขนหรือขาบวมข้างหนึ่ง (ซึ่งเป็นสิ่งเฉพาะ)
- ความรู้สึกปวดแขนหรือขา พบร้อยละ 50-75 ของผู้ป่วยที่มี DVT
- Homan sign คือกระตุ้นให้ปวด จะมีการกระดกเท้าขึ้น
- ป้องกันโดยการใส่ Intermittent pneumatic compression with inflatable sleeves



Swelling



Skin Changes



ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

- 1. ขอบแผลเน่าตาย (flap necrosis) เห็นได้ชัดภายในสัปดาห์แรกหลังผ่าตัด เป็นเพราะแผลตึงเกินไปหรือบางเกินไป หรือมีเลือดออกมากค้างอยู่ในแผลทำให้ skin flap ตึงบวมและหลุดลอยขึ้นจากทรงอก รักษาโดยตัดส่วนที่ตายออก ถ้าเป็นบริเวณกว้างการทำ skin graft จะทำให้แผลหายเร็วขึ้น

● การพยาบาล

- Dressing ตามแผนการรักษา
- สังเกตสิ่งผิดปกติบริเวณแผล ชีด เขียว หรือม่วงชัดเจน
- ให้อาตามแผนการรักษา
- หากแพทย์ไม่สามารถเย็บได้ จะต้องเปิดทำแผล Wet dressing จนกว่าแผลจะแดงดี จึงนำมาทำ skin graft ภายหลัง

ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

- 2. มีเลือดหรือซีรัมคั่งอยู่ใต้แผล (hematoma, seroma) เนื่องจากการผ่าตัด mastectomy ต้องเลาะเข้าใต้ผิวหนังเป็นบริเวณกว้าง หลังผ่าตัดจึงมีเลือดซึมออกได้พอสมควร และต้องป้องกันมิให้คั่งอยู่ในแผลโดยการใส่ท่อระบาย บางครั้งเลือดออกมากหรือท่อระบายอุดตัน ทำให้มีลิ่มเลือดตกค้างและทำให้แผลติดเชื้อหรือขอบแผลเน่าตาย ถ้ามีมากควรเปิดแผลเอาลิ่มเลือดออก ถ้ามีน้อยควรรอให้ลิ่มเลือดละลายและใช้เข็มดูดออกพร้อมกับใช้ผ้าปิดแผลกดทับไว้ (pressure dressing) รายที่มีซีรัมหรือน้ำเหลือง (lymph) คั่งอยู่ก็สามารถรักษาได้ในทำนองเดียวกัน ศัลยแพทย์จะเอา Drain ออกเมื่อมีปริมาณ Seroma ออกน้อยกว่า 30 ซีซีต่อวัน ติดต่อกันนาน 2 วัน

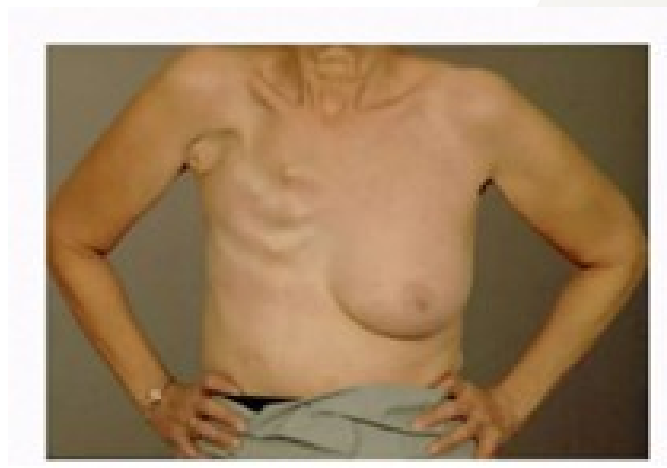
- การพยาบาล

- ดูแลสายระบายบริเวณแผลผ่าตัด
- Observe จำนวน สี สิ่งคัดหลั่งจากขวระบาย
- กดแผลภายนอกบริเวณรักแร้แขนข้างผ่าตัดเบาๆ ช่วยลดการคั่งค้าง
- หลังผ่าตัดใหม่ๆ ยังไม่ควรให้ยกแขนสูงมากนักเพราะจะทำให้ผิวหนังไม่ติดกับกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อบริเวณนั้น
- หากหลังเอาสายระบายออกยังมีซีรั่มคั่ง รายงานแพทย์



ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

- 3. ข้อไหล่แข็งขยับได้น้อยลง เกิดขึ้นเพราะผู้ป่วยเจ็บแผลจึงไม่ขยับแขนและไหล่ข้างนั้น และดิ่งแขนมาแนบตัวตลอดเวลาติดต่อกันหลายวัน ทำให้ข้อหัวไหล่ยึด ป้องกันได้โดยกระตุ้นให้ผู้ป่วยขยับแขนและหัวไหล่แต่เนิ่นๆ ถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องแก้ไขโดยกายภาพบำบัด



● การพยาบาล

- อธิบายความจำเป็นที่จะเพิ่มการเคลื่อนไหวให้ได้สูงสุด
- ให้ยาแก้ปวดที่เหมาะสม
- วัดวงแขนข้างที่ผ่าตัดทั้งก่อนและหลังผ่าตัดเพื่อประเมิน
- ช่วงแรกอาจใช้แขนข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดช่วงพยุงข้างที่ผ่าตัดในการบริหารให้ได้สูงสุด
- ออกกำลังกายแขนทั้งสองข้างวันละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย ทุกวัน ตลอดไป



ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

- 4. แขนบวม การตัดต่อมน้ำเหลืองในรักแร้หรือการฉายรังสีที่รักแร้ ทำให้อ่อน้ำเหลืองอุดตันและแขนบวมได้ เกิดขึ้นหลายเดือนหรือหลายปีหลังการรักษาส่วใหญ่อาการไม่รุนแรง รักษาโดยให้ยกแขนสูง เช่น คล้องแขน ห้อยคอไว้ตอนกลางวัน และวางแขนบนหมอนสูงขณะนอนกลางคืน พันผ้า elastic ตั้งแต่ปลายมือขึ้นมาตลอดทั้งแขน ให้ยาขับปัสสาวะ รายที่เป็นรุนแรงและเรื้อรังเกิน 10 ปี อาจเกิด lymphosarcoma ที่แขนได้ การมีมะเร็งลามในรักแร้ก็ทำให้แขนบวมได้เช่นกัน

● การพยาบาล

- ฝึกการเคลื่อนไหวของไหล่และแขนสม่ำเสมอ
- ยกแขนให้สูง ห้อยแขนขณะนอน และไม่นอนทับแขนข้างผ่าตัด
- สังเกตอาการบวม ชา ปวดข้างที่ผ่าตัด
- ระวังการติดเชื้อแขนข้างที่ผ่าตัด หากมีแผลให้ทำความสะอาดทันที และสังเกตอาการติดเชื้อ
- หลีกเลี่ยงการเจาะเลือด ฉีดวัคซีน ฉีดยา วัดความดัน ยกของหนัก มากกว่า 1 กิโลกรัม สวมเสื้อผ้าที่แน่น แบกกระเป๋าที่มีสายสะพาย ใส่เสื้อชั้นในขนาดใหญ่ หรือไม่มีสายคล้อง



ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

- 5. อาการชาตื้นแขนด้านใน เป็นเพราะเส้นประสาทที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนี้ (intercostobrachial nerve) ถูกตัดขาด อาการจะดีขึ้นเองในที่สุด แต่อาจไม่หายไปทั้งหมด





Thank You

